

PUBMED DAILY WATCH • 2026-06-15

DLBCL / CNSL 新治疗与机制文献 监测

近 7 天官方 PubMed 窗口：2026-06-09 至 2026-06-15。每篇文章单独 1 页 slide，并明确区分已验证证据、论文作者观点和我的推断；本页只做文献监测和研究设计启示，不提供医疗建议。

EDAT 新入库

40

PDAT 发表日期

30

MDAT 记录更新

244

精选文献

10

下载 PDF

下载 PPTX

固定公网链接

检索与筛选说明

PubMed 官方 ESearch/EFetch 于 2026-06-15 检索；窗口为 2026-06-09 至 2026-06-15，合并 EDAT、PDAT、MDAT 覆盖近 7 天新增、发表和记录更新。官方计数为 EDAT 40、PDAT 30、MDAT 244；成功解析去重候选池 240 条。本日按 10 papers/day 和 pubmed-history.json 去重，选择 10 篇未跨日重复 PMID；其中 41580449、41727499、42166746、41633880、41777880、42279281 为 MDAT/EDAT 记录更新或近期高相关参考，已在对应页面明确标注不是近 7 天新发表临床试验。

检索式：((DLBCL[Title/Abstract] OR "diffuse large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR "large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR LBCL[Title/Abstract] OR PCNSL[Title/Abstract] OR "primary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "primary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR CNSL[Title/Abstract] OR "central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract]) AND lymphoma[Title/Abstract])

#	方向	疾病	PMID	标题
1	CNSL / PCNS-DLBCL / 预后分层	primary central nervous system diffuse large B-cell lymphoma	41580449	PCNS-DLBCL 中 POD24 的预后意义：LTE 模型识别早期进展风险
2	双抗 / T-cell engagement / LBCL	large B-cell lymphoma	42273965	LBCL 中双特异性抗体实践：T 细胞重定向治疗进入真实应用阶段
3	BTkI / CAR-T 桥接 / R/R DLBCL	复发/难治 DLBCL	41727499	R/R DLBCL 中 BTkI 桥接 CAR-T：桥接时长、反应和毒性信号
4	双抗 / 患者报告结局 / 时间毒性	复发/难治 FL 与 DLBCL，其中 DLBCL 60 例	42166746	R/R DLBCL 双抗治疗的患者报告时间毒性：glofitamab 与 epcoritamab 负担差异
5	ADC / polatuzumab / loncastuximab / DLBCL 综述	DLBCL，尤其 R/R DLBCL 与部分一线探索场景	41633880	Beyond R-CHOP：DLBCL 中 ADC 的机制、临床证据、毒性和耐药
6	CAR-T / 神经毒性 / CNS 受累病例报告	DLBCL 复发并继发 CNS 受累	41777880	CD19 CAR-T 后非 ICANS 神经毒性：伴继发 CNS 受累 DLBCL 的 MNT 样病例
7	靶向/表观遗传 / 小分子机制 / R/R DLBCL 前临床	DLBCL 细胞系与 SUDHL-4 异种移植模型	41825143	有机砷化合物 CZ2 通过恢复 TMS1 逆转表观遗传耐药并抑制 DLBCL
8	转化研究 / 空间组学 / 肿瘤微环境	DLBCL 高分辨率多重免疫荧光样本	42285950	拓扑数据分析解析 DLBCL 恶性-免疫细胞空间互作并关联生存
9	耐药机制 / 纳米递送 / 转化综述	DLBCL 化疗耐药相关场景	42283995	多功能纳米载体克服 DLBCL 化疗耐药：当前进展与临床挑战
10	机制研究 / 微环境 / WES 与共培养验证	DLBCL，GCB 与 non-GCB 亚型	42279281	DLBCL 肿瘤微环境致病突变：通过肿瘤-基质互作推动进展

PCNS-DLBCL 中 POD24 的预后意义：LTE 模型识别早期进展风险

Prognostic significance of POD24 in primary central nervous system diffuse large B-cell lymphoma: a retrospective study.

PMID 41580449

打开 PubMed

CNSL / PCNS-DLBCL / 预后分层

primary central nervous system diffuse large B-cell lymphoma

MDAT 命中；PubDate 2026-01-24，本轮为 MDAT 更新高相关 CNSL 参考，非近 7 天新发表

P 人群

PCNS-DLBCL 患者

I 干预/暴露

POD24 评估和 LDH-TG-Efficacy 风险模型

C 比较

LTE 高危组 vs 低危组，POD24 vs 非 POD24

O 结局

OS、PFS、POD24 发生率、模型 AUC、敏感度和特异度

结论

这项三中心回顾研究纳入 85 例 PCNS-DLBCL，评估 24 个月内疾病进展（POD24）及其风险因素，并构建 LDH-TG-Efficacy（LTE）模型。摘要显示，年龄 ≥65 岁、治疗无反应和 POD24 是 OS 的独立不良预后因素；POD24 的独立风险因素包括 LDH 升高、甘油三酯升高和治疗无反应。LTE 高危组 POD24 发生率显著高于低危组，模型 AUC 为 0.828。

主要内容

- 纳入 3 家医院 85 例 PCNS-DLBCL，分析 POD24、风险因素和预后模型。
- 全队列 mOS 为 48.54 个月，mPFS 为 39.09 个月。
- OS 独立不良因素包括年龄 ≥65 岁、治疗无反应和 POD24，其中 POD24 HR 25.22。
- POD24 独立风险因素包括 LDH 升高、甘油三酯升高和治疗无反应；LTE 高危组 POD24 发生率 81.8% vs 35%。

关键信息

- 作者：Yuye Shi、Yunjie Li、Xiaohu Xu、Yuan Deng、Hong Tao、Tingting Ji 等。
- 核心数据：85 例 PCNS-DLBCL；POD24 对 OS 的 HR 为 25.22；LTE 模型 AUC 为 0.828。
- CNSL 价值：为 PCNS-DLBCL 早期进展风险识别提供可操作临床变量组合。
- 方向标签：PCNSL、PCNS-DLBCL、POD24、LDH、triglycerides、prognostic model。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要明确报告样本量、mOS/mPFS、OS 独立风险因素、POD24 风险因素、LTE 模型、POD24 发生率和 AUC。

论文作者观点

论文作者观点：POD24 可作为 PCNS-DLBCL 的独立预后指标，LTE 指数可帮助识别 POD24 高风险人群。

我的推断

我的推断：PCNSL 新治疗研究应预设 POD24 或早期进展作为分层/敏感性分析变量，并把 LDH、TG 和早期疗效纳入风险调整；这不是治疗推荐。

LBCL 中双特异性抗体实践：T 细胞重定向治疗进入真实应用阶段

T-cell engagement in practice: bispecifics in large B-cell lymphoma.

PMID 42273965

打开 PubMed

双抗 / T-cell engagement / LBCL

large B-cell lymphoma

EDAT/PDAT/MDAT 命中；2026-06-11 发表，PubMed 记录未提供摘要

P 人群

large B-cell lymphoma 患者

I 干预/暴露

T-cell engaging bispecific antibodies

C 比较

实践综述性质；PubMed 摘要未提供具体比较

O 结局

实践应用框架信号；无可从 PubMed 摘要提取的疗效终点

结论

这篇 Haematologica 文章聚焦 large B-cell lymphoma 中 T-cell engaging bispecifics 的实践应用。PubMed 未提供摘要，因此本页只引用可验证的题名、期刊、日期、文章类型、作者和 DOI；不能从 PubMed 记录中补写具体疗效、毒性管理或患者选择细节。它的监测价值在于提示双抗已经从单纯试验有效性讨论，进入给药流程、毒性识别、序贯治疗和实践管理的证据整合阶段。

主要内容

- 文章题名直接指向 LBCL 中 bispecifics 的实践应用，而不是单一药物注册研究。
- PubMed 记录未列摘要，无法从官方记录确认具体论点、药物清单或管理建议。
- 该条目适合作为双抗方向的专家综述/实践框架信号，与 glofitamab、epcoritamab、mosunetuzumab 等药物使用场景相关。
- 纳入本日监测的理由是近 7 天新增且直接覆盖 LBCL 双抗实践。

关键信息

- 作者：Michele D Stanchina、Juan Pablo Alderuccio。
- 证据边界：无摘要；本页不推断具体疗效或安全性数字。
- 监测价值：提示双抗方向关注点正在从“是否有效”扩展到“如何在 LBCL 中落地”。
- 方向标签：bispecific antibody、T-cell engagement、large B-cell lymphoma、practice。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 记录确认题名、期刊 Haematologica、作者、2026-06-11 发表、文章类型和 DOI。

论文作者观点

论文作者观点：从题名可确认作者讨论 LBCL 中 T-cell engaging bispecifics 的实践应用；具体观点因 PubMed 无摘要，本页不展开。

我的推断

我的推断：双抗文献监测不应只收 ORR/CR，还要追踪实践流程、住院/门诊给药、CRS 管理、固定疗程与序贯治疗问题；这些是推断，不是该 PubMed 记录已证实的细节。

R/R DLBCL 中 BTKi 桥接 CAR-T：桥接时长、反应和毒性信号

Predictors and responses to varying durations of BTK inhibitor bridging therapy before anti-CD19 CAR-T cell therapy in patients with relapsed/refractory DLBCL.

PMID 41727499

打开 PubMed

BTKi / CAR-T 桥接 / R/R DLBCL

复发/难治 DLBCL

MDAT 命中；PubMed 记录本轮更新，原始 PubDate 为 2026，非近 7 天新发表

人群

接受 anti-CD19 CAR-T 的复发/难治 DLBCL 患者

干预/暴露

CAR-T 前 BTK inhibitor 桥接治疗，含 ibrutinib 或 zanubrutinib

比较

较长 BTKi 暴露时长 vs 较短暴露时长

结局

ORR、PFS、OS、NAMPT/PD-1 探索性标志物和血液学毒性

结论

这项回顾性分析评估 33 例 R/R DLBCL 在 anti-CD19 CAR-T 前接受 BTKi 桥接治疗的时长差异。摘要显示，较长 BTKi 暴露组总缓解率更高，但 PFS 和 OS 未见统计学差异；探索性分析提示 NAMPT 和 PD-1 调节可能与 BTKi 桥接效果相关。作者同时提醒延长 BTKi 使用带来的血液学毒性风险。

主要内容

- 研究背景是 anti-CD19 CAR-T 疗效仍需优化，BTKi 如 ibrutinib 或 zanubrutinib 被探索为桥接策略。
- 纳入 33 例具有高危因素的 R/R DLBCL 患者，按 BTKi 暴露时长分组比较。
- 较长 BTKi 桥接组 ORR 更高，但 PFS/OS 未显示统计学差异。
- 探索性生物标志物包括 NAMPT 和 PD-1；延长 BTKi 暴露的血液学毒性需要关注。

关键信息

- 作者：Jia Wang、Rui Cui、Yao Qi、Juan Mu、Xin Li、Qing Li 等。
- 核心方向：BTKi 不只是单药治疗，也可作为 CAR-T 前疾病控制和免疫调节桥接变量。
- 证据边界：33 例回顾性分析，结论不能外推为 BTKi 桥接标准方案。
- 方向标签：ibrutinib、zanubrutinib、BTKi bridging、anti-CD19 CAR-T、R/R DLBCL。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要报告样本量、BTKi 桥接背景、分组依据、ORR、PFS/OS 差异不显著、生物标志物探索和血液学毒性提醒。

论文作者观点

论文作者观点：较长 BTKi 桥接可能改善 CAR-T 反应，但需要进一步研究验证，并需平衡血液学毒性。

我的推断

我的推断：CAR-T 桥接研究可以把 BTKi 暴露时长、输注前疾病负荷、PD-1/NAMPT 等免疫代谢指标纳入分层；当前证据不足以推荐固定桥接时长。

R/R DLBCL 双抗治疗的患者报告时间毒性：glofitamab 与 epcoritamab 负担差异

Patient-reported time toxicity with bispecific antibody therapies in relapsed/refractory follicular lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma.

PMID 42166746

打开 PubMed

双抗 / 患者报告结局 / 时间毒性

复发/难治 FL 与 DLBCL，其中 DLBCL 60 例

MDAT 命中； PubDate 2026-06-06，本轮为近 7 天记录更新/近期高相关参考

P 人群

接受双抗治疗的 R/R FL 和 R/R DLBCL 患者

I 干预/暴露

mosunetuzumab、glofitamab 或 epcoritamab 等双抗治疗体验调查

C 比较

不同双抗方案的访问次数和时间负担；固定疗程 vs 治疗至进展偏好

O 结局

医疗访问次数、月度时间毒性、日常影响和方案偏好

结论

这项在线调查纳入 120 例正在接受双抗治疗的 R/R FL 或 DLBCL 患者，其中 DLBCL 60 例。患者报告过去 30 天医疗访问、治疗、出行、恢复和日常影响。DLBCL 人群中，glofitamab 的月度时间负担低于 epcoritamab（43.0 vs 87.7 小时），且绝大多数患者偏好固定疗程而非治疗至进展。研究强调把患者便利性和时间毒性纳入 NHL 双抗决策。

主要内容

- 研究涵盖 mosunetuzumab、glofitamab、epcoritamab 等已获批双抗的真实世界患者体验。
- DLBCL 组平均过去 30 天 2.6 次医疗访问；glofitamab 访问次数少于 epcoritamab。
- DLBCL 中 glofitamab 月度时间负担低于 epcoritamab：43.0 vs 87.7 小时。
- ≥92% 参与者偏好固定疗程方案，而非治疗至进展方案。

关键信息

- 作者：Ajay Major、Esprit Ma、Anthony Masaquel、Mazie Tsang、Mengyang Di、Supreet Kaur 等。
- 核心指标：time toxicity，把交通、治疗、恢复和日常影响纳入治疗负担。
- 研究价值：补足双抗疗效之外的真实世界患者中心数据。
- 方向标签：bispecific antibody、glofitamab、epcoritamab、DLBCL、patient-reported outcome、fixed duration。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要明确调查样本量、FL/DLBCL 分层、医疗访问次数、月度时间负担、固定疗程偏好和研究结论。

论文作者观点

论文作者观点：不同双抗治疗的时间负担存在有临床意义的差异，患者便利性和偏好应纳入 NHL 共同决策。

我的推断

我的推断：双抗方案设计和市场准入材料中，固定疗程、给药频率、恢复时间和陪护/交通成本会成为疗效之外的重要比较维度；这些不等同于疗效优劣判断。

Beyond R-CHOP：DLBCL 中 ADC 的机制、临床证据、毒性和耐药

Beyond R-CHOP: The rise of antibody-drug conjugates in DLBCL.

PMID 41633880

打开 PubMed

ADC / polatuzumab / loncastuximab / DLBCL 综述

DLBCL，尤其 R/R DLBCL 与部分一线探索场景

MDAT 命中；PubDate 2026 Apr，本轮为 MDAT 更新高相关 ADC 参考，非近 7 天新发表

P 人群

DLBCL 患者，特别是复发/难治及一线强化探索人群

I 干预/暴露

CD79b、CD19、CD22、CD30、CD37 等靶点 ADC

C 比较

传统免疫化疗、不同 ADC 靶点与未来组合策略

O 结局

临床疗效证据、毒性谱、耐药机制和未来研究方向

结论

这篇 Blood Reviews 综述系统梳理 ADC 在 DLBCL 中的机制和证据，重点包括 CD79b 靶向 polatuzumab vedotin、CD19 靶向 loncastuximab tesirine 以及 CD22、CD30、CD37 等在研 ADC。摘要同时强调 ADC 应用仍面临特征性毒性管理、耐药机制和未来组合策略问题。

主要内容

- DLBCL 仍有相当比例患者出现复发/难治，ADC 通过靶向抗原递送细胞毒 payload 扩展治疗景观。
- 已获批或进入关键应用场景的 ADC 包括 polatuzumab vedotin 和 loncastuximab tesirine。
- 在研 ADC 靶点包括 CD22、CD30、CD37 等。
- 综述关注作用机制、更新临床证据、毒性谱、耐药机制和未来管理策略。

关键信息

- 作者：Xiaoxiao Xu、Meichen Liu、Zhenxing Wang。
- 覆盖 ADC 方向：polatuzumab、loncastuximab、CD22/CD30/CD37 ADC。
- 证据性质：综述，不是新增临床试验结果；适合做 ADC 方向地图。
- 方向标签：antibody-drug conjugate、polatuzumab vedotin、loncastuximab tesirine、R/R DLBCL、resistance。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要明确综述对象、ADC 药物、在研靶点、毒性和耐药挑战。

论文作者观点

论文作者观点：ADC 已显著扩展 DLBCL 治疗景观，但毒性管理和耐药机制理解仍是临床转化关键。

我的推断

我的推断：ADC 文献监测应按靶点、payload、既往 CAR-T/双抗暴露、神经病变或血液学毒性分别记录，不能只把 ADC 归为同一类药物。

CD19 CAR-T 后非 ICANS 神经毒性：伴继发 CNS 受累 DLBCL 的 MNT 样病例

Non-ICANS neurotoxicities CD19-directed CAR T-cell therapy and the emergence of movement and neurocognitive treatment-emergent adverse events: a case report.

PMID 41777880

打开 PubMed

CAR-T / 神经毒性 / CNS 受累病例报告

DLBCL 复发并继发 CNS 受累

MDAT 命中；PubMed 记录本轮更新，病例报告并非近 7 天新发表临床试验

人群

接受 CD19 CAR-T 的复发 DLBCL 且伴继发 CNS 受累患者

干预/暴露

axi-cel 后神经毒性观察和激素处理

比较

经典 ICANS 表现与非 ICANS/MNT 样表现的鉴别

结局

延迟神经毒性、运动/认知表现、CSF CAR-T 细胞、NfL 和部分临床恢复

结论

这例 63 岁 DLBCL 患者在 axi-cel 治疗后 day +22 出现延迟神经毒性，既往有 CRS 和 ICANS，基础疾病伴继发 CNS 受累。表现不同于经典 ICANS，呈进行性步态共济失调和运动迟缓等 movement and neurocognitive treatment-emergent adverse events (MNT) 样综合征。作者称这是 CD19 CAR-T 后 MNT 样综合征的首个文献记录病例，并提示需要超越 ICANS 的诊断警惕。

主要内容

- 患者接受 CD19 CAR-T axi-cel，基础 DLBCL 复发并有继发 CNS 受累。
- day +22 出现延迟神经毒性，主要为共济失调、运动迟缓、认知处理速度下降等 MNT 样表现。
- 无影像学进展、感染或淋巴瘤复发证据；CSF 中以 CAR-T 细胞为主，血清/CSF NfL 升高。
- 激素治疗后部分改善，但随访神经心理测试仍有注意和处理速度缺陷。

关键信息

- 作者：Torsten Schroeder、Guranda Chitadze、Justina Dargvainiene、Tjark Martens、Niklas Gebauer、Julia Frimmel 等。
- 核心安全性信号：CD19 CAR-T 也可能出现非经典 ICANS 的运动/神经认知毒性。
- CNS 相关性：基础疾病继发 CNS 受累，是高风险神经毒性背景。
- 方向标签：CD19 CAR-T、axi-cel、DLBCL、secondary CNS involvement、MNT、neurotoxicity。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要报告病例表现、时间点、CNS 受累背景、CSF/外周免疫表型、NfL 升高、激素反应和作者安全性结论。

论文作者观点

论文作者观点：该病例拓宽 CD19 CAR-T 神经毒性谱，提示即使在 CD19 靶向场景也需关注 ICANS 之外的 MNT 样综合征。

我的推断

我的推断：CNSL 或继发 CNS 受累患者的 CAR-T 研究应预设更细的神经毒性采集，包括运动症状、认知量表、CSF 免疫细胞和 NfL；单个病例不能估计发生率。

有机砷化合物 CZ2 通过恢复 TMS1 逆转表观遗传耐药并抑制 DLBCL

Epigenetic reprogramming by organic arsenic CZ2 elicits potent antitumor responses in DLBCL through TMS1 restoration.

PMID 41825143

打开 PubMed

靶向/表观遗传 / 小分子机制 / R/R DLBCL 前临床

DLBCL 细胞系与 SUDHL-4 异种移植模型

PDAT 命中; 2026-06-15 发表, 近 7 天新发表机制研究

人群

DLBCL 细胞系、正常 PBMC 对照和 SUDHL-4 异种移植模型

干预/暴露

有机砷化合物 CZ2

比较

三氧化二砷及未处理/对照条件

结局

细胞存活、凋亡、DNMT 活性、TMS1 甲基化/表达、肿瘤生长和生存

结论

研究开发有机砷化合物 CZ2, 并在 DLBCL 细胞系和异种移植模型中评估抗肿瘤活性。摘要显示, CZ2 比三氧化二砷具有更强体外效力, 诱导线粒体损伤和 caspase 级联凋亡; 机制上抑制 DNMT1/3A/3B, 导致 TMS1 去甲基化和表达恢复。体内实验显示肿瘤生长和重量下降、生存改善。作者认为 CZ2 可能成为克服表观遗传介导耐药的潜在策略。

主要内容

- 体外使用 SUDHL-4、SUDHL-6 等 DLBCL 细胞系, 并以正常 PBMC 作为重要安全性对照。
- CZ2 IC50 约 0.67 μM , 较 ATO 2.21 μM 更低, 并呈剂量/时间依赖性降低 DLBCL 细胞存活。
- 机制涉及线粒体完整性破坏、caspase 3/7/9 激活、DNMT 抑制、TMS1 去甲基化和表达恢复。
- SUDHL-4 xenograft 中验证抗肿瘤效应, 表现为肿瘤生长和重量下降、生存改善。

关键信息

- 作者: Wennei Mei、Mingzhu Zhang、Dongdong Zhang。
- 研究阶段: 前临床机制研究, 不是人体治疗证据。
- 核心机制: DNMT 抑制 -> TMS1 恢复 -> 线粒体凋亡通路激活。
- 方向标签: DLBCL、epigenetic reprogramming、DNMT、TMS1、organic arsenical、CZ2、drug resistance。

启示

已验证证据

已验证证据: PubMed 摘要报告实验体系、IC50、PBMC 对照、凋亡检测、DNMT/TMS1 机制、甲基化验证和 xenograft 结果。

论文作者观点

论文作者观点: CZ2 通过靶向 DNMT 和恢复 TMS1 展示较强选择性和抗 DLBCL 潜力, 支持进一步开发和理性联合研究。

我的推断

我的推断: 这类研究的转化关键在于选择性、安全窗和与现有 DLBCL 方案的联合逻辑; 目前只能作为机制启示, 不能写成临床可用治疗。

拓扑数据分析解析 DLBCL 恶性-免疫细胞空间互作并关联生存

Spatial analysis of malignant-immune cell interactions in the tumor microenvironment using topological data analysis.

PMID 42285950

打开 PubMed

转化研究 / 空间组学 / 肿瘤微环境

DLBCL 高分辨率多重免疫荧光样本

EDAT/PDAT/MDAT 命中; 2026-06-13 发表, 近 7 天新增/发表记录

P 人群

DLBCL 多重免疫荧光图像样本

I 干预/暴露

TopMR 与 signed distance-density 空间分析框架

C 比较

不同空间互作聚类 and 恶性富集区/肿瘤边界区

O 结局

可解释空间特征、患者分层和生存结局关联

结论

该研究提出结合拓扑数据分析和统计模型的空间特征框架, 用 Topological Malignant Region (TopMR) 定义恶性细胞区域, 再用 signed distance-density 空间描述全局浸润和局部互作。作者将该框架应用于 DLBCL 多重免疫荧光图像, 分别分析恶性富集区和肿瘤边界区, 并通过两阶段层次聚类发现空间互作模式与生存结局相关。

主要内容

- 研究目标是提取可解释的恶性细胞与免疫细胞空间互作特征, 并连接患者结局。
- TopMR 使用拓扑持久性自动定义恶性细胞区域, 即使肿瘤边界不清也能提供空间参考。
- 全局尺度用免疫细胞到 TopMR 边界的 signed distance, 局部尺度用免疫细胞周围恶性细胞密度。
- DLBCL 图像分析显示空间互作聚类与生存结局相关。

关键信息

- 作者: Seol Ah Park, Davide Gurnari, Pawel Dlotko, Yongsoo Kim, Jooyoung Hahn.
- 核心价值: 把 DLBCL 微环境从细胞比例推进到空间互作和区域边界分析。
- 证据性质: 方法学/转化研究, 提供风险分层和伴随诊断思路, 不直接给治疗方案。
- 方向标签: DLBCL, topological data analysis, tumor microenvironment, multiplex immunofluorescence, survival.

启示

已验证证据

已验证证据: PubMed 摘要明确 TopMR、signed distance-density、DLBCL 多重免疫荧光应用、层次聚类和生存关联。

论文作者观点

论文作者观点: 区域感知的空间分析可以捕捉与患者生存相关的生物学模式, 并形成从特征提取到临床解释的流程。

我的推断

我的推断: 免疫治疗、双抗和 CAR-T 研究可考虑把空间微环境特征作为解释低反应或复发风险的协变量; 但该方法还需要外部验证和标准化。

多功能纳米载体克服 DLBCL 化疗耐药：当前进展与临床挑战

Overcoming chemotherapy resistance in diffuse large B-cell lymphoma using multifunctional nanocarriers: current advances and clinical challenges.

PMID 42283995

打开 PubMed

耐药机制 / 纳米递送 / 转化综述

DLBCL 化疗耐药相关场景

EDAT/PDAT/MDAT 命中; 2026-06-12 发表, 近 7 天新增/发表记录

P 人群

DLBCL 耐药相关模型和未来患者场景

I 干预/暴露

靶向纳米载体、基因递送和组合递送系统

C 比较

传统药物递送或未靶向递送策略

O 结局

耐药降低、再敏化、off-target 减少、转化可行性和安全性挑战

结论

这篇综述聚焦 DLBCL 化疗耐药中的纳米载体策略, 讨论靶向递送、基因治疗、组合治疗、CXCR4 和 TFR1 靶向, 以及 miRNA/siRNA 递送降低耐药和再敏化的可能性。作者同时指出, 生物屏障、规模化、安全性和靶向特异性仍限制临床转化。

主要内容

- DLBCL 化疗耐药是主要治疗挑战之一, 纳米载体被用于提高药物递送、减少耐药和降低 off-target 暴露。
- 综述覆盖靶向递送、基因治疗、组合治疗和刺激响应释放系统。
- 重点讨论 CXCR4、TFR1、miRNA 和 siRNA 递送对耐药通路的潜在影响。
- 转化挑战包括生物屏障、规模化生产、安全性和靶向特异性。

关键信息

- 作者: Danyang Li, Xiaoyan Ke, Kai Hu。
- 核心方向: 不是某一个上市药, 而是 DLBCL 耐药递送平台和组合策略。
- 证据性质: 综述, 提出研究方向和转化挑战。
- 方向标签: DLBCL、chemoresistance、nanocarrier、CXCR4、TFR1、miRNA、siRNA。

启示

已验证证据

已验证证据: PubMed 摘要明确纳米载体用途、CXCR4/TFR1、miRNA/siRNA、组合递送和临床转化挑战。

论文作者观点

论文作者观点: 多功能纳米载体有望缓解 DLBCL 耐药, 但需要优化设计并通过临床前和临床研究验证。

我的推断

我的推断: 耐药文献监测应把药物机制、递送系统和患者分层分开记录; 纳米载体方向目前更多是平台启示, 不应被写成近期可用治疗选择。

DLBCL 肿瘤微环境致病突变：通过肿瘤-基质互作推动进展

Pathogenic Mutations in the Tumor Microenvironment Drive Tumor Progression in Diffuse Large B-Cell Lymphoma Through Tumor-Stroma Cross-Talk.

PMID 42279281

打开 PubMed

机制研究 / 微环境 / WES 与共培养验证

DLBCL, GCB 与 non-GCB 亚型

EDAT/MDAT 命中; PubDate 2026-05-22, 本轮为 EDAT/MDAT 更新, 非近 7 天新发表

人群

DLBCL 患者样本, 含 GCB 与 non-GCB 亚型

干预/暴露

WES、基因表达/通路分析和原代共培养验证

比较

不同亚型、不同基质/ECM 突变和肿瘤-基质组合条件

结局

EFS/OS 异质性、突变谱、通路富集和 Th2/Th17 细胞因子变化

结论

研究分析 DLBCL 中基质相关基因突变、表达和下游通路, 纳入 113 例有完整临床数据患者。WES 发现 TNFAIP3、NFIB、NOTCH1、TSC2、EZH2、EP300、KMT2D、B2M 等复发突变及基质/ECM 相关新突变; 通路涉及 Notch、Wnt、mTOR、JAK-STAT、TGF- β 和抗原呈递。共培养验证显示含肿瘤细胞和基质成分条件下 Th2/Th17 相关细胞因子升高, 支持微环境参与 DLBCL 进展。

主要内容

- 176 例筛查, 113 例纳入完整临床数据分析; 43.4% 为 GCB-DLBCL, 56.6% 为 non-GCB DLBCL。
- IPI 仍与 EFS/OS 相关, 但相似风险组内仍有明显异质性。
- WES 识别多种肿瘤和表观遗传调控基因突变, 并提示基质/ECM 相关突变具有功能相关性。
- 原代共培养中, 肿瘤细胞加基质成分条件下 IL-4、IL-6、IL-10、IL-17 等升高。

关键信息

- 作者: Vaishali Aggarwal、Radhika Srinivasan、Amanjit Bal、Pankaj Malhotra、Subhash Varma、Ashim Das 等。
- 核心机制: 肿瘤-基质 cross-talk 可能通过细胞因子和通路激活推动进展。
- 研究价值: 把 DLBCL 风险从肿瘤内在突变扩展到微环境突变和功能验证。
- 方向标签: DLBCL、tumor microenvironment、WES、stroma、JAK-STAT、TGF-beta、antigen presentation。

启示

已验证证据

已验证证据: PubMed 摘要报告样本量、GCB/non-GCB 构成、WES 突变、通路富集、基质相关突变、共培养细胞因子结果。

论文作者观点

论文作者观点: 微环境和基质相关突变具有功能意义, 可能通过肿瘤-基质互作参与 DLBCL 进展。

我的推断

我的推断: 双抗、CAR-T 和 ADC 低反应机制研究可加入 TME 突变、抗原呈递和炎症细胞因子作为解释变量; 但现阶段还不能据此决定具体治疗策略。

今日综合判断 • 2026-06-15

今日重点不是单个药名，而是 CNS 预防、双抗固定疗程、CAR-T 前处理药代和免疫微环境分层这些可改变研究设计的变量。

已验证证据

本轮官方候选池成功解析 240 条，精选 10 篇未重复 PMID：41580449、42273965、41727499、42166746、41633880、41777880、41825143、42285950、42283995、42279281。已验证证据覆盖 PCNS-DLBCL POD24 预后分层、LBCL 双抗实践、BTKi 桥接 CAR-T、双抗时间毒性、ADC 综述、CAR-T 非 ICANS 神经毒性病例、表观遗传小分子 C22、DLBCL 空间微环境分析、纳米载体耐药综述和微环境致病突变机制。

论文作者观点

论文作者共同指向的方向是：DLBCL/CNSL 研究正在从单一疗效数字转向更复杂的治疗路径问题，包括 PCNS-DLBCL 早期进展风险如何识别、双抗如何进入真实实践、CAR-T 前桥接和后续神经毒性如何量化、ADC 如何管理耐药和毒性，以及微环境/空间结构如何解释复发和免疫治疗低反应。

我的推断

我的推断是：近期最值得持续追踪的变量包括 CNS 复发风险分层、治疗时间毒性、CAR-T 前 BTKi 桥接质量、非经典神经毒性、ADC 耐药机制、空间微环境和基质相关突变。以上仅用于文献监测和研究设计启示，不构成治疗推荐；MDAT 更新条目应与近 7 天新发表临床试验分开解读。

固定本地文件：pubmed-pages/index.html。固定公网链接：<https://zhengyi-pharmacy-collab.github.io/pubmed-lymphoma-slides/>。PubMed 链接均使用 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/\[PMID\]/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/[PMID]/) 格式。